De 10-punten lijst voor de jaarcontrole DM type-2 door de huisarts

"Niet alleen vinken maar ook vonken", streef naar individualisering van zorg = maatwerk

Jan Palmen, *huisarts en kaderarts DM*, Aarveld Medisch Centrum, Heerlen

1.HbA1C, streefwaarde	NB bij veel comorbiditeit wordt de ziektelast leidend en niet het HbA1c			
	• **< 70 jaar** of > **70 jaar** **<u>én</u>** alleen leefstijl of metformine	«	(7,0%)	53 mmol/mol
	• **> 70 jaar**			
	• → **én** diabetes duur < 10 jaar	«	(7.5%)	58 mmol/mol
	• → **én** diabetes duur > 10 jaar	«	(8,0%)	64 mmol/mol
	• Is de medicatie optimaal (start met metformine , preferent SU; gliclazide)			*Ja/Neen*
	• Is de medicatie maximaal (preferent insuline; NPH –insuline)			*Ja/Neen*
	• Is er sprake van hypoglykemieën			*Ja/Neen*
	• Is er sprake van een depressieve stoornis, *overweeg 4 DKL-lijst, WHO-5-vragenlijst*			*Ja/Neen*
	• Is er sprake van cognitieve achteruitgang, *overweeg MMSE*			*Ja/Neen*
OVERWEEG VERWIJZING OF CONSULTATIE (kaderhuisarts)	→ **HbA1C > 8,5 % (ONDANKS INTENSIEVE CONTROLES GEDURENDE 6 MND)** → **BIJ TWIJFEL AAN DIAGNOSE DM type-2, *LADA, MODY*** → **RECIDIVERENDE (ERNSTIGE) HYPOGLYKEMIEËN** → **OMZETTING NAAR INSULINE BIJ MORBIDE OBESITAS BMI > 35 kg/m²**			

2.MICRO-ALBUMINURIE		
	• Aanwezig	*Ja/Neen*
	• Is een ACE of AII voorgeschreven *(NB **<u>niet</u>** combineren)*	*Ja/Neen*
	NB streefwaarde bloeddruk SBD < 130 mm Hg	
OVERWEEG VERWIJZING OF CONSULTATIE	→ **PROGRESSIEVE MICROALBUMINURIE (ONDANKS MAX BEHANDELING ANTIHYPERTENSIVA)** → **MACRO-ALBUMINURIE > 200 mg/l = 300 mg/24 uur ALTIJD VERWIJZEN!!**	

3.KLARING		
	30ml/min < eGFR > 60ml/min	
	• Is patiënt geruiterd **ICPC code U99.1**	*Ja/Neen*
	• eGFR < 30 ml/min	*Ja/Neen*
	• Gebruikt patiënt metformine → dosering aanpassen !	*Ja/Neen*
	• Is de apotheker geïnformeerd	*Ja/Neen*
NB verlaging eGFR altijd in relatie zien met leeftijd, micro-albuminurie en RR. ***Gouden standaard is 24-uurs urine***		
Bepalen bij lager geschatte eGFR tussen 30 en 60 ml/min		
Overweeg bepaling Hb, K, Ca, P, PTH, Albumine en Sediment		
OVERWEEG VERWIJZING OF CONSULTATIE (kaderhuisarts)	→ **LEEFTIJD < 65JR EGFR 30-60 ml/min/1.73 m2, OVERLEG NEFROLOOG** → **LEEFTIJD > 65 JR EGFR 30-45 ml/min/1.73 m2, OVERLEG NEFROLOOG** → **SPECIFIEKE SEDIMENTSAFWIJKINGEN; VERMOEDEN ONDERLIGGENDE NIERZIEKTE** → **KREATININEKLARING < 30 ml/min(MDRD). 24-UURS URINE METING**	

4.BLOEDDRUK		
	• Is de systolische bloeddruk < 140 mmHg (HCTZ, ACE of ARB, Ca-ant,ß-blokker)	*Ja/Neen*
	• Is de medicatie optimaal (preferente: Ca-antagonist, amlodipine, ß-blokker, metoprolol)	*Ja/Neen*
	• Is de medicatie maximaal	*Ja/Neen*
	• Is er sprake van orthostatische hypotensie • **Cardiovasculair risico ; AP, claudicatio, tekenen van hartfalen**	*Ja/Neen* *Ja/Neen*
NB Uiting van cardiovasculaire autonome neuropathie NB bij 80+ streefwaarde SBD < 160 mmHg		
OVERWEEG VERWIJZING OF CONSULTATIE	→ **SBD » 140 MMHG ONDANKS DRIE OF MEER ANTI-HYPERTENSIVA** → **THERAPIE RESISTENTE HYPERTENSIE / TRH**	

5.CHOLESTEROL

- Gebruikt patiënt statine *Ja/Neen*
- *Simvastatine 1 dd 40mg*
- Streefwaarde « 2,5 mmol/l bereikt *Ja/Neen*

*NB leeftijd 80+ en DM niet standaard statine als **primaire** preventie*

OVERWEEG VERWIJZING OF CONSULTATIE (kaderhuisarts)

- → **NIET HALEN VAN DE STREEFWAARDE < 2,6 MMOL/L NA EEN JAAR ONDANKS MAXIMALE THERAPIE EN HOOG RISICOPROFIEL (>20%)**
- → **VERDENKING FAMILIAIRE HYPERCHOLESTEROLEMIE (TC > 8,0 mm/l) RATIO >8 mm/l EN LDL > 5 mm/l**
- → **TRIGLYCERIDEN > 6,0 mm/l: raadpleeg www.STOEH.nl (familiaire hypercholesterolemie)**

6. DIABETISCHE NEUROPATHIE DN 4 (NB alleen bij indicatie Vitamine B-12 bepaling)

Vraag 1. Vertoont de pijn een of meerdere van de volgende kenmerken

1. 1.Branderig gevoel *Ja/Neen*
2. 2.Pijnlijk koudegevoel *Ja/Neen*
3. 3.Elektrische schokken *Ja/Neen*

Vraag 2. Is de pijn in hetzelfde gebied geassocieerd met of meerdere van de volgende symptomen

4. Kriebels *Ja/Neen*
5. Tintelingen *Ja/Neen*
6. Gevoelloosheid *Ja/Neen*
7. Jeuk *Ja/Neen*

Vraag 3. Lichamelijk onderzoek door arts

8. Hypo-esthesie bij aanraking (minder huidgevoel) *Ja/Neen*
9. Hypo-esthesie bij een prik (minder pijngevoel) *Ja/Neen*

Vraag 4. Pijn bij wrijven

10. Pijn wordt versterkt door wrijven *Ja/Neen*

Indien score > 4 hoogstwaarschijnlijk sprake van Neuropathie overweeg behandeling (TCA eerste keus)

OVERWEEG VERWIJZING OF CONSULTATIE (kaderhuisarts)

- → **THERAPIERESISTENTE EN SYMPTOMATISCHE POLYNEUROPATHIE**
- → **CALLUSVORMING EN/OF AFWEZIGE VOETPULSATIES**
- → **NEURO-ISCHAEMISCHE HOOGRISICOVOET, VERLIES PROTECTIEVE SENSIBILITEIT**
- → **DIABETISCH ULCUS**
- → **SIMMS CLASSIFICATIE obv verlies PS (protectieve sensibiliteit) en PAV (perifeer arterieel vaatlijden)**

Simms 0; geen verlies PS en PAV/ zorg; HA/POH-er/controle 1x 12 mnd.
Simms 1; verlies PS of PAV zonder drukplekken/ zorg; HA/POH-er/ Medisch Pedicure /controle 1x 6mnd.
Simms 2; verlies PS en PAV of drukplekken of beide, of:verlies PS icm met verhoogde druk, of: verlies PS en PAV icm verhoogde druk / zorg; Podotherapeut /controle 1x 3 mnd.
Simms 3; ulcus of amputatie in voorgeschiedenis/ zorg; Podotherapeut en/ of Voetenteam /controle1x 1-3 mnd

7. SEXUELE DYSFUNCTIE, INCONTINENTIE

Man erectiele dysfunctie,verlies libido
Gebruik β-blokker? Gebruik ACE-remmer? *Ja/Neen*
Vrouw: lubricale dysfunctie, verlies libido
Overweeg PDE-5 remmer bij de man.

8. POLYFARMACIE

Overweeg sanering medicatie. Vraag expliciet naar de compliance, controleer zo nodig. *Ja/Neen*

9. GEBITSSTATUS

Let op parodontitis, gingivitis en roken *Ja/Neen*
Advies : tweemaal per jaar *tandarts of mondhygiëniste*

10.VALACCIDENTEN

Overweeg hypoglykemie, orthostatische hypotensie, medicatie, DNP, slechte visus, LJM en krachtsverlies. *Ja/ neen*

©juli 2014